

Ciało utknęło w niedokończonej reakcji

Trauma „zamraża” reakcje obronne w ciele. Sensorimotor: dokończenie niedokończonych ruchów (walka, ucieczka) w bezpiecznym kontekście, w oknie tolerancji.

CZAS: 1–3 lata, 50–90 min sesja **REALIZACJA:** Faza 2 lub równolegle z Fazą 1

ŹRÓDŁO: Ogden, Minton & Pain (2006, *Trauma and the Body*); Ogden & Fisher (2015, *Sensorimotor Psychotherapy manual*); Fisher (2015, traumatyczne dysocjacje); Siegel (1999, okno tolerancji)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery wzorce ciała w traumie:** zamrożona walka (napiecie), zamrożona ucieczka (chroniczne pobudzenie), zamrożona porażka (postawa zapadnięta), odcięcie (dysocjacja somatyczna). W sekcji 02 — **cztery techniki:** uważność ciała, eksploracja impulsu, dokończenie ruchu, somatyczny *grounding*. Sekcja 03 — **twoja mapa ciała:** gdzie jest napięcie, jaki ruch chce się dokończyć. Sekcja 04 — pytania do specjalisty Sensorimotor.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sensorimotor Psychotherapy (Ogden, Minton & Pain, 2006, *Trauma and the Body*; Ogden & Fisher, 2015) to podejście integrujące pracę z *ciałem* (oddolne, ang. *bottom-up*) z przetwarzaniem *poznawczym i emocjonalnym* (odgórne, *top-down*). Pat Ogden (2006): w traumie ciało „utknęło” w **niedokończonych reakcjach obronnych:** (1) *zamrożona walka* — chroniczne napięcie mięśniowe; (2) *zamrożona ucieczka* — chroniczne pobudzenie, niepokój ruchowy; (3) *zamrożona porażka* — postawa zapadnięta (ang. *collapsed posture*), opadnięte ramiona, „*poddanie*”; (4) *odcięcie* — dysocjacja somatyczna, „*nie czuję ciała*”. Cel terapeutyczny: **dokończenie** niedokończonych reakcji obronnych w bezpiecznym kontekście terapii — pacjent *doświadcza* impulsu, jaki chciałby zrealizować (uciec, odepchnąć, walczyć), i *realizuje go* w mikroformie (powolny ruch, gest, postawa) w oknie tolerancji. Praca odbywa się w *oknie tolerancji* (Siegel, 1999) — terapeuta *monitoruje* pobudzenie pacjenta i *moduluje* intensywność (zbyt dużo = dysregulacja, zbyt mało = brak zmiany). **Techniki:** (a) *uważność ciała* — „*co zauważasz teraz w ciele?*” — *nie* interpretacja, obserwacja; (b) *eksploracja impulsu* — „*twoje ramiona się napinają — co chciałby zrobić?*” (popchnąć, pociągnąć, uciec); (c) *dokończenie ruchu* — „*pozwól ramionom zrobić, to co chcą*” — w bezpiecznym tempie; (d) *somatyczny grounding* — stopy na podłodze, pion kręgosłupa, oddech. Fisher (2015): Sensorimotor szczególnie skuteczna w C-PTSD, gdzie *werbalne* przetwarzanie jest niewystarczające lub *retraumatyzuje*. **Praktyczna implikacja:** klientka po latach przemocy zamarza w sytuacjach konfrontacji — ciało nieruchomieje, oddech się zatrzymuje. Wie, że „*powinna walczyć*”, ale ciało nie reaguje. *Odgórna* praca (CBT, terapia rozmowna) *nie* dociera do somatycznego zamrożenia. Sensorimotor: śledzenie sensacji somatycznych w sesji, eksperymenty z mikroruchami — gdzie ciało chce iść? (rzucić, odepchnąć, uciec); dokończenie niedokończonych reakcji obronnych w bezpiecznej przestrzeni; integracja z narracją. Praca *powolna*, w oknie tolerancji, z tytułacją.

01



Cztery wzorce ciała w traumie

ZAMROŻONA WALKA

Chroniczne napięcie.

Ramiona, kark, szczęka. Zaciśnięte pięści. Reakcja walki, której nie można było wykonać.

ZAMROŻONA UCIECZKA

Chroniczne pobudzenie.

Niepokój ruchowy, „*nie mogę usiedzieć*”, drżenie. Reakcja ucieczki, która nie miała ujęcia.

ZAMROŻONA PORĄŻKA

Postawa zapadnięta.

Opadnięte ramiona, pochylona głowa, „*poddanie*”. Reakcja „już się nie opieram”.

ODCIĘCIE

Dysocjacja somatyczna.

„*Nie czuję ciała*”, analgezja, brak propriocepcji. Reakcja „*nie jestem tu*”.

02 Cztery techniki Sensorimotor

A · UWAGA NA CIEŁO

„Co zauważasz teraz w ciele?” Nie interpretacja — obserwacja. Napięcie, temperatura, ruch, drżenie. Cel: *kontakt z ciałem, bez agendy.*

B · EKSPLOACJA IMPULSU

„Twoje ramiona się napinają — co chciałyby zrobić?” Popchnąć, pociągnąć, uciec, walnąć. Wsluchanie w impuls, jaki ciało *chciało* wykonać.

C · DOKOŃCZENIE RUCHU

„Pozwól ramionom zrobić to, co chcą — powoli.” Mikroruch w bezpiecznym tempie, w oknie tolerancji. Pacjent *doświadcza* dokończenia.

D · SOMATYCZNY GROUNDING

Stopy na podłodze, pion kręgosłupa, oddech. Powrót do tu i teraz. Zakotwiczenie w ciele jako bezpiecznej bazy.

03 Moja mapa ciała + pytania do specjalisty

GDZIE W MOIM CIELE JEST NAJWIĘCEJ NAPIĘCIA

— ramiona, kark, szczeka, brzuch, klatka, miednica; od jak dawna

JAKA JEST MOJA TYPOWA POSTAWA

— zapadnięta? zaciśnięta? otwartana? co mówi o niedokończonej reakcji

JAKI RUCH „CHCE SIĘ DOKOŃCZYĆ” W TRUDNYCH SYTUACJACH

— popchnąć? uciec? walnąć? skulić się? bez ocen

PYTANIA DO SPECJALISTY SENSORIMOTOR

— „czy masz certyfikat Sensorimotor Psychotherapy Institute?”, „jak pracujesz przy dysocjacji w sesji?”

Klucz: Sensorimotor Psychotherapy jest szczególnie wskazana w C-PTSD, gdzie werbalne przetwarzanie nie wystarcza lub retraumatyzuje. Trauma żyje w ciele — w chronicznym napięciu, postawie, oddechu, sposobie reagowania na bodźce. Sama rozmowa nie sięga do tego poziomu. Ogden i Fisher (2015): „ciało jest bramą do nieświadomości” — nawet pacjenci, którzy nie pamiętają traumy słownie, mają zapisane wzorce somatyczne. Dokończenie niedokończonych reakcji obronnych w bezpiecznym kontekście terapii daje ciało doświadczenie sprawczości: „mogę odpychać, mogę uciekać, mogę walczyć”. To kluczowe dla osób, które w dzieciństwie *nie mogły* się obronić — ich ciało *nie wie*, że już mogą.

△ Sensorimotor wymaga specjalistycznego treningu (Sensorimotor Psychotherapy Institute — SPI, USA/międzynarodowe certyfikaty). „Praca z ciałem” bez tego treningu może być powierzchowna lub szkodliwa — dokończenie ruchu poza oknem tolerancji jest retraumatyzujące. Pytaj specjalistę o certyfikat. Praktyki samodzielnie (joga, taniec, ruch) są pomocne jako uzupełnienie, nie zastąpienie terapii sensomotorycznej.